

Опыт применения препарата Септонест в местной анестезии при малых гинекологических операциях.

Ли В.В., Абдулаханова Р.Р.

Медицинский центр «КАУ», г.Алматы,

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей

Актуальность

Лечение больных с доброкачественными заболеваниями влагалищных частей шейки матки является одной из основных проблем гинекологии. Важность этой проблемы обусловлена сравнительно большой частотой заболеваний, недостаточной эффективностью лечения, а также определённой вероятностью злокачественного перерождения. Патология шейки матки наблюдается у 38,8% женского населения и у 49% гинекологических больных.

В настоящее время так называемые малые гинекологические операции, преследующие диагностическую и лечебную цель, представлены в виде различных видов коагуляции и конизации тканей, ножевой биопсии тканей шейки матки, вульвы, влагалища, аспирационной биопсии эндометрия, диагностического выскабливания цервикального канала и т.д. Все хирургические вмешательства нуждаются в адекватном обезболивании.

Традиционным методом анестезии в амбулаторно-поликлинических условиях является местная парацервикальная новокаиновая блокада. В результате блокируется висцеральная сенсорная иннервация шейки матки и верхней части влагалища на уровне околошеечного сплетения. При проведении широких радикальных диатермохирургических вмешательств (высокая конизация шейки матки, широкая плоскостная экцизия) для достижения должного эффекта анестезии увеличивается доза вводимого новокаина до 20-40 мл., что создаёт определённые технические неудобства при выполнении манипуляции. Нередки случаи индивидуальной непереносимости новокаина и центральные отложенные реакции: заторможенность, сонливость.

Прослеживая аналогию в строении слизистой оболочки, подслизистого слоя, волокнистых элементов и кровеносных сосудов полости рта и слизистой влагалищной части шейки матки, недостаточный местноанестезирующий эффект новокаина, нами предлагается альтернативный метод местного анестезиологического пособия. Анестетики, широко и с большим успехом, применяющиеся в стоматологии могли бы быть эффективны при проведении малых гинекологических операций.

В качестве местных анестетиков, нами предлагаются препараты из группы амидов: лидокаин, тримикаин, артикаин, подавляющие рецепторную возбудимость и блокирующие проведение импульсов по нервным волокнам. Из препаратов артикаинового ряда большой опыт применения имеет препарат типа септонест в стандартном разведении 1:100 000 и 1:200 000. Септонест, обладая высокой липидной растворимостью, проявляет выраженный анестезирующий эффект, а высокий уровень связывания с протеинами обуславливает низкую токсичность препарата. Септонест обладает рядом преимуществ при его использовании:

- удобная система карпульного шприца с определённым необходимым объёмом картриджа или количества препарата

- малые дозы препарата позволяют достигнуть хорошего обезболивающего эффекта; достаточно объёма одного картриджа 1,7 мл септонеста против 10-20 мл 0,5% рас-

Опыт применения препарата септонест в местной анестезии при малых гинекологических операциях

Лечение больных с доброкачественными заболеваниями влагалищных частей шейки матки является одной из основных проблем гинекологии. Важность этой проблемы обусловлена сравнительно большой частотой заболеваний, недостаточной эффективностью лечения, а также определённой вероятностью злокачественного перерождения.

В качестве анестетика предлагается препарат септонест, который проявляет выраженный анестезирующий эффект и низкую токсичность.

Цель исследования - оценка целесообразности применения анестетика типа септонест в гинекологической практике.

Материалы и методы: В исследование включены 2096 пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями женских половых органов, которым проводились малые гинекологические хирургические и диагностические вмешательства в амбулаторно-поликлинических подразделениях г. Алматы с 1995 по 2010 год.

При отсутствии аллергических реакций в течение 3-5 минут, анестетик вводится в нескольких точках удаляемой или резецируемой тканей. При выполнении широких диатермоконизаций или диатермоэкцизий, предпочтительными точками введения препарата является участки шейки матки, свободные от обильного кровоснабжения: предположительно 9,11,15,17 часов условного циферблата.

Результаты показали, что препарат можно рекомендовать в качестве местноанестезиологического пособия в гинекологической практике.

Experience in use of the drug septonest in local anesthesia for small gynecological operations.

Treatment of patients with benign diseases of the vaginal part of the cervix is a major problem gynecology. The urgency of this problem is caused by the relatively high frequency of diseases, insufficient treatment efficacy, and also specific probability of malignant transformation

The purpose of the study - assessment of the feasibility of anesthetic type septonest in gynecological practice

Material Methods: The study included 2,096 patients with background and precancerous diseases of female genital mutilation, which were minor gynecological, surgical and diagnostic interventions in the outpatient departments poliklieicheskikh Almaty from 1995 to 2010. As an anesthetic drug septonest proposed, which exhibits a pronounced anesthetic effect and low toxicity. The results showed that the drug can be recommended as a locally anesthesia in gynecological practice.

твора новокаина

- отсутствие практически побочных реакций, хорошая переносимость

- гемостатический эффект, за счёт резкого сужения сосудов на местном уровне, с достижением высокой концентрации анестетика локально и профилактикой подслизистых кровоизлияний

- быстрый последующий обратимый эффект ингибирования чувствительности вегетативных, сенсорных и моторных нервных волокон.

Перечисленные позитивные возможности препарата септонест могут явиться альтернативой при его применении в гинекологической практике при обезболивании хирургических вмешательств на слизистых оболочках репродуктивных органов.

Цель исследования

Оценка целесообразности применения местного анестетика типа септонест в гинекологической практике для улучшения возможностей местной анестезии.

Материалы и методы

В исследование включены 2096 пациенток с фоновыми и предраковыми заболеваниями женских половых органов, которым проводились малые гинекологические хирургические и диагностические вмешательства в амбулаторно-поликлинических подразделениях г. Алматы с 1995 по 2010 год. Пациентки были представлены всеми возрастными группами (табл.1)

Таблица 1 - Распределение больных с доброкачественной патологией гениталий по возрасту

Репродуктивный возраст до 40 лет	1560	74,4%
Климактерический период 41-50 лет	332	15,8%
Ранний менопаузальный возраст 50 лет и старше	204	9,7%
	2096	

Во всех возрастных группах, при выполнении хирургических манипуляций на шейке матки, цервикальном канале, вульве, влагалище и т.д., в качестве местного анестетика использовался препарат септонест в стандартном разведении.

Септонест - комбинированный препарат для местной анестезии, с действующим началом атракаин, обладающий высоким анестезирующим эффектом и хорошей переносимостью. Действие препарата начинается через 3-4 минуты после инъекции, с продолжительностью анестезирующего эффекта в мягких тканях не менее одного часа. Стандартное разведение препарата 1:100 000 для обеспечения более длительного эффекта анестезии и 1:200 000 при малых объемах лечебных и диагностических вмешательств.

Для введения препарата используется система карпульного шприца, применяемого, в основном, в стоматологии. Для определения индивидуальной чувствительности к препарату, рекомендуется сублингвальная или внутрикожная проба. При отсутствии аллергических реакций в течение 3-5 минут, анестетик вводится в нескольких точках удаляемой или резецируемой тканей. При выполнении широких диатермокоагуляций или диатермоэксцизий, предпочтительными точками введения препарата является участки шейки матки, свободные от обильного кровоснабжения: предположительно 9,11,15,17 часов условного циферблата. Анестетик вводится в стандартной дозе 1,7 мл (1 картридж), с помощью карпульного шприца, в подслизистый слой, на границе поражения, в пределах здоровой ткани.

Скорость введения препарата: 1,7 мл в течение 1 минуты. С целью исключения подэпителиальных кровоизлияний рекомендуется аспирационный контроль. Через 2-3 минут проба электродом на болевую реакцию и при её отсутствии дальнейшие необходимые местные вмешательства. Доза препарата может индивидуализироваться в зависимости от объёма патологической ткани и индивидуальной чувствительности пациентки.

Результаты исследования

При клиническом исследовании 2096 пациенток, которым проводились малые гинекологические операции и диагностические манипуляции с применением местного анестетика типа септонест, виды хирургических вмешательств были распределены следующим образом (табл.2)

Таблица 2 - Виды мало гинекологических операций и диагностических манипуляций.

Диатермохирургические вмешательства	1829	87,26%
Прицельная биопсия	75	3,57%
Удаление кондилом, папиллом, эндометриодных кист	28	1,3%
Аспирационная биопсия	36	1,7%
Окклюзия цервикального канала	20	1%
Полипэктомия с выскабливанием ложа	34	1,6%
Биопсия слизистой цервикального канала	33	1,6%
Введение ВМС	41	1,95%
	2096	

В подавляющем большинстве случаев (87,26%) септонест в качестве местного анестетика использовался при диатермохирургических вмешательствах по типу диатермокоагуляция, диатермоэксцизия, диатермокоагуляция шейки матки. Во всех случаях произведённых диатермохирургических операций отмечалось отсутствие болевых реакций и ощущений на фоне местной анестезии септонестом. Для купирования болевого синдрома при взятии аспирационной биопсии эндометрия у 36 женщин (1,7%) расширении цервикального канала при его окклюзии у 20 (1%) женщин и т.д., применение септонеста позволило более качественно провести эти вмешательства с наибольшим комфортом для пациентки, с продолжительным обезболивающим эффектом.

Септонест при малых хирургических вмешательствах на гениталиях переносился хорошо и практически без побочных эффектов. От 0,05-0,3% (1-7 случаев) отмечались тахикардия, тошнота, связанные больше с поведенческими реакциями, лабильностью и эмоциональностью пациенток. В нашей практике дозирование местного анестетика проводилось индивидуально: для купирования окклюзии цервикального канала достаточно Уг стандартной дозы препарата, а при большом объёме патологического очага и большей длительности вмешательства, применялось до 1,5 картриджей.

Таким образом, учитывая:

- выраженный, продолжительный обезболивающий эффект препарата в сочетании с достаточно хорошей переносимостью

- практическое отсутствие побочных эффектов

- возможность широкого применения в амбулаторных условиях при малых гинекологических и диагностических манипуляциях

- использование малого количества анестетика без каких-либо технических неудобств, способствующих более комфортному исполнению вмешательств и обеспечивающих качественный диагностический, лечебный и косметический эффект, можно рекомендовать данный

метод местноанестезиологического пособия в гинекологической практике

Список использованной литературы

1. Рудакова О.Б. Псевдозерозия шейки матки. Автореф. дисс. д.м.н.- Омск, 1996.
2. Новикова М.Ю. Лейкоплакия шейки матки. Авторефер. Дисс. к.м.н.-1995.
3. Шаров Д.В.. Стоматология. –М.: ВладосПресс, 2005.
4. Максимовский Ю.М., Максимовская Л.Н., Орехова Л.Д. Терапевтическая стоматология.- М.: Медицина, 2002.
5. Mathilde E. Boon, Albert J.H. Suurmeijer. The Pap Smear, Leiden, 1991.